

Cabestrillo mediouretral (para incontinencia de esfuerzo)

WARWIKI

Información para el paciente · Una cirugía rápida y eficaz para el escape de orina por esfuerzo

El cabestrillo mediouretral es la cirugía más común para la **incontinencia urinaria de esfuerzo femenina** — escape de orina al toser, reír, levantar peso o hacer ejercicio. Se coloca una tira angosta de malla suave bajo la mitad de la uretra para sostenerla, de modo que se mantenga cerrada cuando sube la presión. Es rápida, suele ser ambulatoria, y es muy eficaz y duradera.

Acerca de este procedimiento

Por una pequeña incisión dentro de la vagina, se coloca una cinta delgada **sin tensión** bajo la mitad de la uretra, como una hamaca. Cuando usted tose o hace fuerza, la uretra presiona contra el cabestrillo y se mantiene cerrada. **No hay nada que operar** después — funciona por sí solo. Existen distintas vías (retropúbica y transobturatriz) y cabestrillos “mini” de una incisión; su cirujano elegirá el mejor para usted.

Acerca de la malla

El cabestrillo mediouretral sintético es uno de los procedimientos **más estudiados** en la salud de la mujer, con sólida seguridad y éxito a largo plazo. Es **diferente** de la malla transvaginal usada para el prolapso que generó advertencias de la FDA. Si prefiere evitar la malla sintética, un cabestrillo hecho de **su propio tejido** (cabestrillo de fascia autóloga) es una alternativa.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Incontinencia de esfuerzo

Escape con la presión — al toser, reír, levantar peso.

Cabestrillo mediouretral

Una cinta de malla que sostiene la mitad de la uretra.

Sin tensión

El cabestrillo descansa bajo la uretra sin apretarla.

Retropúbica / transobturatriz

Dos vías que puede tomar el cabestrillo; ambas funcionan bien.

Cabestrillo autólogo

Un cabestrillo hecho de su propio tejido en vez de malla.

Exposición de la malla

Problema poco común donde un poco de malla se hace visible; tratable.

¿LE DOLERÁ? Se hace con anestesia (general o espinal), así que no siente nada durante la cirugía, y suele durar menos de 30 minutos. La mayoría va a **casa el mismo día** con leve molestia y vuelve pronto a la actividad ligera.

Cómo prepararse

- Siga sus **instrucciones de anestesia** (ayuno, suspenda los anticoagulantes según le indiquen).
- Un **análisis de orina** para descartar infección; a veces pruebas de la función vesical antes.
- Consiga quien lo lleve; planee tareas ligeras por un par de semanas.

Qué sucede

- 1 Está dormida o adormecida; se administran antibióticos.
- 2 Se hace una pequeña incisión vaginal y se coloca la cinta sin tensión bajo la mitad de la uretra.
- 3 Los puntos de salida (sobre el pubis o en la ingle) cierran solos; se cierra la incisión vaginal.
- 4 Suele orinar antes de irse a casa para confirmar que vacía bien.

Después de la cirugía

- Es normal una leve molestia y un poco de manchado.
- **Evite levantar peso, hacer fuerza y las relaciones sexuales unas 6 semanas.**
- A veces se necesita una sonda brevemente si al inicio vacía despacio.

Llame a su equipo si tiene:

- **No puede orinar** o siente que no vacía
- Fiebre o sangrado abundante
- Dolor que empeora, o luego dolor con el sexo o flujo vaginal (posible problema de malla)

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. El cabestrillo mediouretral sostiene la uretra para frenar el escape por esfuerzo — rápido, ambulatorio, muy eficaz y sin nada que operar después.
2. Su malla está bien estudiada y es distinta de la malla de prolapso retirada; un cabestrillo de tejido propio es una opción si lo prefiere.
3. Evite peso y sexo ~6 semanas. Llame si no puede orinar, tiene fiebre, o luego dolor/flujo.